Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Passo Fundo

Rua General Neto, 486 - Bairro: Centro - CEP: 99010022 - Fone: (54) 3046-9100 - Balcão Virtual (54) 99630-2223 - Email: frpasfundo5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5016765-96.2024.8.21.0021/RS

AUTOR: CARLOS EDUARDO GORSKI

RÉU: UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

RÉU: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

SENTENÇA

Vistos.

CARLOS EDUARDO GORSKI ajuizou a presente "ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada" em face de **UNIMED PLANALTO MÉDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAUDE LTDA.** e **UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**, todos qualificados nos autos, narrando que é beneficiário de plano de saúde operado pela ré Unimed do Estado do Paraná. Informou que se encontra em tratamento psiquiátrico contínuo desde 09/12/2015, tendo sido diagnosticado com Transtorno Depressivo Recorrente – episódio atual grave, sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2), e ideação suicida grave e estruturada. Sustentou que seu quadro clínico é refratário aos tratamentos convencionais, tendo feito uso de diversas medicações sem alcançar resposta terapêutica satisfatória ou por não tolerar os efeitos colaterais. Referiu que a médica psiquiatra que o acompanha prescreveu tratamento com o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina), a ser administrado em regime de hospital-dia. Aduziu que, apesar da expressa indicação médica, da aprovação do fármaco pela ANVISA e de sua eficácia comprovada por estudos científicos e recomendada por agências internacionais, as rés negaram a cobertura do tratamento sob a alegação de que o medicamento não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS e por se tratar de medicamento para uso domiciliar. Argumentou que a negativa é abusiva, uma vez que o tratamento não é de uso domiciliar, mas sim ambulatorial e de aplicação assistida por profissional de saúde. Discorreu sobre a aplicabilidade do CDC e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, uma vez que o pedido administrativo foi operacionalizado pela Unimed Planalto Médio, embora o contrato seja com a Unimed Paraná. Por fim, requereu: a) em sede de tutela de urgência, que as rés fossem compelidas a fornecer e custear imediatamente o tratamento prescrito; b) a confirmação da tutela, determinando a condenação das rés à obrigação de fazer. Juntou documentos (evento 01).

Foi comprovado o recolhimento das custas iniciais (evento 02).

A tutela provisória de urgência de natureza antecipada foi deferida, determinando que as rés fornecessem o medicamento Spravato com aplicação na modalidade hospital-dia (evento 04).

Citada (evento 16), a ré Unimed Planalto Médio/RS apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva *ad causam*, ao argumento de que o contrato de plano de saúde do autor foi firmado exclusivamente com a corré Unimed do Estado do Paraná, sendo pessoas jurídicas distintas e autônomas, ainda que integrantes do mesmo sistema cooperativo. Afirmou que sua atuação se limita à operacionalização de atendimentos via intercâmbio, mediante autorização da Unimed de origem. Por fim, pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito em relação a si (evento 22).

Citada (evento 25), a ré Unimed do Estado do Paraná apresentou contestação, defendendo a legalidade da negativa da solicitação, uma vez que o medicamento Spravato não possui cobertura para uso ambulatorial, o que encontraria amparo na Lei nº 9.656/98. Alegou que a utilização do fármaco para o quadro do autor carece de comprovação científica robusta, impugnando os laudos e estudos apresentados. Argumentou que a imposição de cobertura para tratamentos não previstos no contrato e no rol da ANS gera desequilíbrio econômico-financeiro para a operadora, com impacto para a coletividade de beneficiários. Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos. Sucessivamente, pleiteou a autorização para cobrança de coparticipação e a determinação de apresentação de relatórios médicos trimestrais pelo autor. Juntou documentos (evento 23).

Houve réplica (evento 27).

Indeferiu-se a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Unimed Planalto Médio. Na mesma oportunidade, foi invertido o ônus da prova e as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir (evento 32).

A ré Unimed Planalto Médio manifestou desinteresse na produção de outras provas (evento 37).

A ré Unimed Paraná requereu a produção de prova pericial e/ou a expedição de parecer ao NATJUS (evento 41).

O autor manteve-se silente (evento 38).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo às razões de decidir.

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito e não havendo necessidade de produção de provas em audiência, reputa-se cabível o julgamento antecipado da lide, conforme expressa o artigo 355, inciso I, do CPC.

Cuida-se de ação cominatória, na qual o autor postula o fornecimento do medicamento Spravato, a ser injetado via intranasal, na modalidade hospital-dia, tendo em vista ser diagnosticado com Transtorno Depressivo Recorrente – episódio atual grave, sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2), e ideação suicida grave estruturada.

De início, cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, uma vez que a relação estabelecida entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo, sendo a autora consumidora (art. 2º do CDC) e a ré fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

Por oportuno, verifico que há questão pendente de análise.

DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PARECER DO NATJUS E/OU DE PROVA PERICIAL

A ré Unimed do Estado do Paraná requereu a produção de prova pericial e/ou a expedição de parecer ao NATJUS (evento 41, PET1).

No entanto, no caso em apreço, a controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental já acostada ao processo, que se revela ampla e suficiente para a formação de um juízo de convicção seguro.

Isso porque os relatórios médicos detalhados (evento 1, ATESTMED2 e evento 27, ANEXO3), a bula do medicamento requerido (evento 23, ANEXO7), as notas técnicas do próprio Sistema Natjus (evento 23, ANEXO4, evento 23, ANEXO5 e evento 41, ANEXO2) e a própria negativa administrativa da operadora (evento 1, INDEFERIMENTO3) fornecem um arcabouço probatório robusto e apto a elucidar os pontos controvertidos da demanda.

A questão central não reside em uma dúvida de ordem estritamente médica sobre a patologia do autor ou sobre a composição do fármaco, mas sim na interpretação jurídica acerca dos limites da cobertura do plano de saúde frente a uma prescrição médica específica.

Portanto, trata-se de uma questão de direito, que envolve a análise de cláusulas contratuais, da Lei nº 9.656/98 e das normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A produção de prova pericial ou a solicitação de parecer ao Natjus se mostraria, nesse contexto, uma medida procrastinatória, que apenas retardaria a prestação jurisdicional em uma demanda que versa sobre o direito fundamental à saúde e à vida, contrariando os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Destaco que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 e 371 do CPC.

O sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, autoriza o magistrado a apreciar livremente as provas produzidas nos autos, desde que indique na decisão as razões que lhe formaram o convencimento, o que realizei no presente caso.

Dessa forma, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da causa, **indefiro o pedido de produção de prova pericial e de expedição de parecer pelo Natjus**.

Sendo assim, não havendo questões preliminares e processuais pendentes de análise, passo ao cotejo do mérito.

DO MÉRITO

A) Do fornecimento do medicamento SPRAVATO

A controvérsia central da lide reside na obrigatoriedade ou não de as operadoras de plano de saúde rés custearem o tratamento do autor com o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina), prescrito por sua médica assistente para tratamento de Transtorno Depressivo Recorrente refratário e ideação suicida grave e estruturada.

Por sua vez, a ré Unimed Paraná baseia-se na alegação de que o tratamento seria de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura obrigatória, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98.

Contudo, a argumentação exposta pela demandada Unimed Paraná não se sustenta diante das provas dos autos e da própria natureza do medicamento, denotando interpretação equivocada e restritiva da legislação e da natureza do tratamento.

Isso pois, o laudo médico emitido pela Dra. Bruna Chaves Lopes (CRM/RS 27859 e RQE 18089) é categórico ao afirmar que *"a aplicação da medicação será realizada na modalidade de Hospital-dia, conforme regulamentada a indicação de seu uso" (evento 1, ATESTMED2).*

Inclusive, a bula do medicamento SPRAVATO, juntada pela própria ré, corrobora tal informação, ao prescrever que o medicamento deve ser utilizado com supervisão de profissional da saúde, devendo o paciente permanecer no estabelecimento hospitala para monitoriamente até ser considerado clinicamente estável (evento 23, ANEXO7).

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Spravato® é administrado em conjunto com outro antidepressivo oral.

Você mesmo irá aplicar **Spravato®** spray nasal, sob a supervisão do seu médico em um hospital ou em uma clínica.

Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e você será monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento.

Seu médico irá demonstrar como usar o dispositivo de spray nasal (veja também "Instruções de Uso" abaixo). Um dispositivo de spray nasal libera dois jatos (um jato para cada narina).

Aliás, a própria embalagem do medicamento informa que seu uso é restrito a hospitais, conforme apontado na réplica (evento 27, RÉPLICA1).

Isto é, não se trata de um medicamento a ser adquirido em farmácia e autoadministrado pelo paciente em sua residência, mas sim de um procedimento terapêutico complexo, realizado em regime ambulatorial ou de hospital-dia, que exige infraestrutura e acompanhamento médico especializado.

Desse modo, a negativa baseada na exclusão de cobertura para uso domiciliar é manifestamente infundada e abusiva, haja vista que a cobertura para tratamentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, é obrigatória, nos termos do artigo 12, inciso I, "b", da Lei nº 9.656/98.

Logo, resta inequivocamente demonstrado que o tratamento com SPRAVATO não se caracteriza como de uso domiciliar, mas sim como tratamento ambulatorial de aplicação assistida, que exige estrutura clínica e supervisão profissional constante, o que afasta por completo a incidência da cláusula de exclusão invocada pela ré.

Outrossim, ainda que o tratamento não conste expressamente do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a sua cobertura é devida, haja vista que a Lei nº 14.454 incluiu os parágrafos 12 e 13 ao artigo 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos e procedimentos não listados no referido rol.

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.*

Assim, no caso dos autos, o autor cumpriu satisfatoriamente com os requisitos legais, uma vez que a eficácia do medicamento é atestada pela sua aprovação pela ANVISA[1], que demonstra a robustez da evidência científica que suporta o uso da escetamina para depressão resistente ao tratamento.

Detalhe do Produto: SPRAVATO

Nome do Produto	SPRAVATO	**Complemento da Marca**		**Número do Processo**	25351.068398/2019-41
Número da Regularização	112363435	**Data da Regularização**	03/11/2020	**Vencimento da Regularização**	11/2030
Empresa Detentora da Regularização	JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA	**CNPJ**	51.780.468/0001-87	**AFE**	1.01.236-1
Princípio Ativo	cloridrato de escetamina			**Categoria Regulatória**	Novo
Medicamento de referência	-				
Classe Terapêutica	ANTIDEPRESSIVOS			**ATC**	
Tipo de Priorização	Ordinária	**Parecer Público**	Acesse aqui		
Bulário Eletrônico	Acesse aqui	**Rotulagem**	• LAYOUTS.PDF - 1 de 1		

Expandir Todas

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	140 MG/ML SOL SPR NAS CT FR VD TRANS X 0,2 ML + DISP INAL (28 MG) Ativo	1123634350014	Solução Spray	03/11/2020	36 meses
2	140 MG/ML SOL SPR NAS CT 2 FR VD TRANS X 0,2 ML + 2 DISP INAL (56 MG) Ativo	1123634350022	Solução Spray	03/11/2020	36 meses
3	140 MG/ML SOL SPR NAS CT 3 FR VD TRANS X 0,2 ML + 3 DISP INAL (84 MG) Ativo	1123634350030	Solução Spray	03/11/2020	36 meses

Voltar

Ademais, o laudo médico menciona expressamente a recomendação por agências internacionais de renome, como a G-BA (Alemanha), SMC (Escócia) e HAS (França), preenchendo o requisito do inciso II do § 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98 (evento 1, ATESTMED2).

Além disso, a alegação da ré Unimed Paraná de que o medicamento carece de comprovação científica, baseada em pareceres técnicos unilaterais (evento 23, ANEXO4, evento 23, ANEXO5 e evento 41, ANEXO2), não pode se sobrepor à prescrição do médico assistente, que acompanha o paciente há quase uma década e possui as melhores condições para definir a terapêutica mais adequada.

Insta salientar que o plano de saúde não pode interferir na autonomia do profissional médico, substituindo seu juízo técnico por uma análise administrativa que visa, em última instância, à limitação de custos.

Por fim, o argumento genérico de que o custeio do tratamento causaria desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato não merece acolhida, tendo em vista que a ré não apresentou qualquer cálculo ou demonstração concreta de que a cobertura deste tratamento específico teria o condão de comprometer a sustentabilidade da carteira de beneficiários.

Ressalto que o mutualismo, princípio basilar dos contratos de seguro e de planos de saúde, pressupõe que a coletividade de segurados arcará com os custos de tratamentos de alto valor eventualmente necessários a alguns de seus membros. Ou seja, a recusa, neste contexto, viola a própria finalidade do contrato, que é garantir a assistência à saúde, e a boa-fé objetiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

> *DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ESCETAMINA INTRANASAL (SPRAVATO). BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. FÁRMACO DE USO AMBULATORIAL. DEVER DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado na ação em que se objetiva seja a ré compelida a fornecer medicamento de uso ambulatorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.* ***A matéria controvertida, devolvida a este grau de jurisdição, refere-se ao dever de cobertura da operadora do plano de saúde em fornecer o medicamento Escetamina Intranasal (SPRAVATO), prescrito pelo médico assistente da autora considerando quadro de transtorno de Depressão Grave - Transtorno Depressivo Recorrente - Episódio atual grave, suicida grave e Automutilação (CID-10 F 33.2)****. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme os artigos 10 e 12 da Lei dos Planos de Saúde, bem como a RN 465/2021 da ANS, é lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo os de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.* ***4. No caso dos autos, conforme analisado em sede de julgamento do agravo de instrumento, extrai-se, do site da ANVISA, que o medicamento postulado - cloridrato de escetamina - é indicado "em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda." 5. A partir da bula do medicamento - nome comercial Spravato -, afere-se a descaracterização do uso domiciliar, vez que "Uma sessão de tratamento consiste na administração nasal de Cloridrato de Escetamina e na observação pós-administração sob a supervisão de um profissional de saúde. Cloridrato de Escetamina deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento."*** *6. Não merece prosperar o argumento recursal relativo à DUT 109 da ANS, uma vez que a administração do fármaco pleiteado não foi prescrita para ser realizada em hospital-dia psiquiátrico. Somado a isso, a obrigatoriedade legal de fornecimento do medicamento de uso ambulatorial não se restringe a pacientes internados ou em terapia oncológica ou imunobiológica.* ***7. Sendo assim, verificando-se que o medicamento postulado não é de uso domiciliar, mas sim ambulatorial, com supervisão de um profissional da área da saúde, configura-se, portanto, o dever de cobertura por parte da operadora do plano de saúde.*** *8. Por fim, não merece guarida o pedido subsidiário para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, uma vez que, conforme o art. 85, §8, do CPC, esta forma de arbitramento é cabível quando, dentre outros casos, o valor da causa for muito baixo, o que não se encaixa na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: arts. 10 e 12 da Lei dos Planos de Saúde (9656/98). Resolução Normativa nº 465/2021, da ANS. Jurisprudência relevante citada: n/a.(Apelação Cível, Nº 50057182220248210023, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-06-2025) - grifei.*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA.* ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLORIDRATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO). TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA A PATOLOGIA. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE NECESSITA REALIZAR TRATAMENTO PARA A PATOLOGIA MEDIANTE USO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO), EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSOANTE LAUDO MÉDICO****.* ***FORNECIMENTO DEFERIDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA***

DEVIDA. *SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50021828320248212001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 18-06-2025) - grifei.*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ***PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO.*** *DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE DETERMINOU A COBERTURA DO MEDICAMENTO SPRAVATO PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO E CONDENOU A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.A OPERADORA APELANTE SUSTENTOU QUE A NEGATIVA DE COBERTURA FOI LÍCITA, POIS O MEDICAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS E NÃO FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA COBERTURA. INSURGIU-SE, AINDA, CONTRA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALEGANDO QUE A NEGATIVA DECORREU DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL PLAUSÍVEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE HÁ OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO MEDICAMENTO SPRAVATO, DIANTE DE SUA CLASSIFICAÇÃO COMO DE USO AMBULATORIAL; E (II) VERIFICAR SE A NEGATIVA DE COBERTURA, AMPARADA EM INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO CONTRATO E DO ROL DA ANS, ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. III. RAZÕES DE DECIDIR4.* ***O MEDICAMENTO SPRAVATO POSSUI ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AMBULATORIAL, CONFORME SUA BULA, EXIGINDO MONITORAMENTO PROFISSIONAL. ASSIM, NÃO SE ENQUADRA NA EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98, SENDO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE.5. O STJ FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS OU INTRAVENOSOS QUE NECESSITAM DE SUPERVISÃO MÉDICA NÃO SÃO CONSIDERADOS DE USO DOMICILIAR E, PORTANTO, NÃO PODEM SER EXCLUÍDOS DA COBERTURA ASSISTENCIAL.****6. QUANTO AO DANO MORAL, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ RECONHECE QUE A NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO, QUANDO BASEADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E NA AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA, NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.7. NO CASO CONCRETO, EMBORA A NEGATIVA DE COBERTURA TENHA SIDO INCORRETA, DECORREU DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL PLAUSÍVEL, SEM DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU ABUSO, AFASTANDO-SE A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. IV. DISPOSITIVO E TESE8. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.****TESE DE JULGAMENTO: "1. O MEDICAMENTO SPRAVATO (ESKETAMINA), POR SER DE USO AMBULATORIAL E EXIGIR ADMINISTRAÇÃO SOB SUPERVISÃO PROFISSIONAL, DEVE SER COBERTO PELOS PLANOS DE SAÚDE, INDEPENDENTEMENTE DE SUA PREVISÃO NO ROL DA ANS.*** *2. A NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RAZOÁVEL NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, DANO MORAL INDENIZÁVEL." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: LEI Nº 9.656/98, ART. 10, VI.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO RESP 2.155.621/PB, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª TURMA, J. 14.10.2024; STJ, AGINT NOS ERESP 1.895.659/PR, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2ª SEÇÃO, J. 29.11.2022; STJ, AGINT NO RESP 2.108.519/SP, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4ª TURMA, J. 15.04.2024.(Apelação Cível, Nº 50168487520248210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 20-03-2025) - grifei.*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ***COBERTURA DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). USO AMBULATORIAL. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO****. DEVER DE COBERTURA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINANDO A COBERTURA PELA DEMANDADA DO MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DO TRATAMENTO POSTULADO EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL, NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR3.* ***EMBORA AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE ESTEJAM DISPENSADAS DE FORNECER MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, EXCETO ANTINEOPLÁSICOS, NO CASO CONCRETO, É INCONTROVERSO QUE O MEDICAMENTO SOLICITADO É DE USO AMBULATORIAL. 4. O MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR DE QUE TRATA O ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 É AQUELE PRESCRITO PELO MÉDICO, ADQUIRIDO DIRETAMENTE NAS FARMÁCIAS E AUTOADMINISTRADO PELO PACIENTE, DIFERENTE DO CASO DOS AUTOS ONDE O MEDICAMENTO PRESCRITO SERÁ ADMINISTRADO EM AMBULATÓRIO, COM SUPERVISÃO MÉDICA. 5. O ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS É TAXATIVO, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NA LEI Nº 14.454/2022, COMO EFICÁCIA COMPROVADA POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS OU RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃOS TÉCNICOS RECONHECIDOS. 6. EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO SPRAVATO PARA PACIENTES COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, QUE JÁ TENHAM TENTADO DIVERSOS OUTROS TRATAMENTOS SEM SUCESSO. 7. CONFIGURADA HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS E DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO, SENDO DEVIDA A COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO****. IV. DISPOSITIVO8. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50058092520238211001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-02-2025) - grifei.*

Com efeito, o autor desincumbiu-se do seu ônus probatório, consoante disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, de comprovar: a) a obrigatoriedade do uso ambulatorial do medicamento Spravato; b) a eficácia do medicamento Spravato para o seu diagnóstico (Transtorno Depressivo Recorrente refratário e ideação suicida grave e estruturada); e c) a recomendação da ANVISA para tratamento do seu diagnóstico.

Somado a isso, o artigo 19, inciso III, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS prevê cobertura obrigatória para atendimento em hospital-dia para tratamento de transtornos mentais, *in verbis*:

> *Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para:*
>
> *III - atendimento em hospital-dia para o tratamento de transtornos mentais, de acordo com o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa;*

Destarte, acolho a pretensão cominatória do autor, tendo em vista que é dever do plano de saúde réu prestar a cobertura do tratamento solicitado (fornecimento do medicamento SPRAVATO).

Portanto, **condeno as rés, solidariamente, à obrigação de fornecer o medicamento Spravato ao autor e custear o tratamento necessário à sua aplicação, conforme disposto no atestado médico (evento 1, ATESTMED2)**.

B) Da coparticipação

A ré Unimed Paraná pleiteia, sucessivamente, a autorização para cobrança de coparticipação, nos termos previstos na cláusula 10.1 do contrato acostado aos autos (evento 23, CONTR2).

Por sua vez, o autor, em réplica, sustenta que a cobrança é indevida, pois o tratamento ocorre pelo regime de hospital-dia.

Compulsando o contrato firmado entre as partes (evento 23, CONTR2), depreende-se que a cláusula 10.1 prevê a cobrança de coparticipação para determinados procedimentos. Contudo, o autor argumenta que o tratamento se enquadra na isenção prevista na cláusula 10.1.2 para internações.

A cobrança de coparticipação pelos planos de saúde é legítima, estando prevista no artigo 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98, como fator moderador de custeio, de forma a proporcionar mensalidades mais módicas, desde que devidamente prevista no contrato, de forma clara e legível, e não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor.

Embora o autor tenha argumentado que o tratamento ocorre em regime de "hospital-dia", vislumbro que a modalidade não afasta a natureza ambulatorial do procedimento para fins de incidência da coparticipação.

Inclusive, não deve ser aplicada ao caso concreta a cláusula 10.1.2. do contrato (evento 23, CONTR2), uma vez que é nítido que o autor não permanecerá sucessivamente por 31 dias internado, ou seja, não é caso de internação psiquiátrica.

Ainda, destaco que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a aplicação da coparticipação nos moldes contratualmente previstos represente um ônus excessivo ou um obstáculo ao acesso ao tratamento, de modo a inviabilizá-lo.

Desse modo, sendo a coparticipação um instituto contratual e legalmente previsto, e não havendo demonstração de sua abusividade no caso concreto, o pedido sucessivo da ré merece acolhimento.

Sendo assim, acolho o pedido de cobrança de coparticipação, devendo ser observadas as cláusulas 10.1.1. do contrato celebrado entre as partes.

> **10.1.1. FICA ESTABELECIDA A COPARTICIPAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS ABAIXO DESCRITOS, POR PARTE DOS BENEFICIÁRIOS DESTE CONTRATO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) POR PROCEDIMENTO, A SER PAGA PELO CONTRATANTE DIRETAMENTE À CONTRATADA.**
>
> **Parágrafo primeiro. Haverá coparticipação em consultas com médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais, realizadas em consultório e pronto socorro, fisioterapias, acupunturas, exames e procedimentos de diagnose e terapia, realizados em consultório médico, em clínicas, laboratórios e hospitais, em regime ambulatorial, incluindo materiais, medicamentos, honorários e taxas relacionadas à execução dos procedimentos.**
>
> **Parágrafo segundo. A coparticipação será cobrada por procedimento realizado e não por amostra, ou seja, em um exame de sangue, por exemplo, retira-se uma amostra para realização de exames, mas é possível realizar vários exames/procedimentos. Nesta hipótese a coparticipação incidirá sobre a quantidade de exames/procedimentos realizados na amostra.**

Portanto, **as rés ficam autorizadas à cobrança de coparticipação, observando as especificações postas na cláusula 10.1.1. do contrato (evento 23, CONTR2)**.

C) Da apresentação de relatório médico

A ré Unimed do Estado do Paraná pleiteia que o autor seja compelido a apresentar relatórios médicos trimestrais sobre a evolução de seu tratamento.

Por sua vez, o autor, em réplica, anuiu expressamente com tal pedido.

Nesse sentido, verifico que a solicitação é razoável e se justifica pela natureza de trato contínuo da obrigação de custeio do tratamento pleiteado pelo demandante.

Ou seja, a apresentação de relatórios periódicos permite à operadora acompanhar a necessidade da manutenção da terapia, a sua eficácia e a adesão do paciente, garantindo a adequada gestão dos recursos e a continuidade do tratamento de forma justificada.

Entretanto, infere-se que não há necessidade de que os relatórios médicos sejam apresentados de forma trimestral, tendo em vista a quantidade de aplicações do medicamento e a necessidade inicial de adesão ao medicamento, conforme atestado médico (evento 1, ATESTMED2).

FASE INDUÇÃO: Aplicar Spravato 84mg (3 dispositivos de 28mg) por via intranasal 2 (duas) vez por semana, durante 4 semanas em sessões assistidas por um profissional de saúde e dias alternadas. Por exemplo segunda e quarta ou terça e quinta.
Total de sessões: 8
Total de dispositivos para essa fase: 24 dispositivos de Spravato® 28mg cada

FASE DE MANUTENÇÃO (segundo e terceiro mês): Aplicar Spravato 84 mg (3 dispositivos de 28mg) por via intranasal 1 (uma) vez por semana durante 8 semanas em sessões assistidas por um profissional de saúde e em dias alternados.
Total de sessões: 8
Total de dispositivos para essa fase: 24 dispositivos de Spravato® 28mg cada

Total de dispositivos solicitados para 3 meses de tratamento: 48 dispositivos de 28mg cada

Após esse período o paciente vai ser avaliado para verificar a evolução do tratamento. Vale lembrar que este tratamento é finito, sendo que o tratamento deve ser seguido por, pelo menos, 6 (seis) meses de acordo com avalição e acompanhamento médico .

Insto é, a apresentação de relatório médico semestral mostra-se adequado e razoável ao presente caso, havendo, inclusive, a referida indicação pela médica assistente do autor.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

> *RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTOS. IPERGS-SAÚDE. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA, EM PARTE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONCESSÃO DO MEDICAMENTO MEDIANTE AVALIAÇÃO PERÍODICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE APLICÁVEIS ÀS AÇÕES QUE ENVOLVEM PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. I. Em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais, tais como celeridade, simplicidade, economicidade, entendo que a sentença bem enfrentou a questão, motivo pelo qual deve ser confirmada, em parte, pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95. II. Está fundada na lei a responsabilidade do IPERGS em fornecer o atendimento médico e hospitalar, assim como os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento da doença que acomete o autor, o que inclui o medicamento postulado. III. Não pode o IPERGS negar o fornecimento do medicamento postulado sob o fundamento de que não há cobertura para o tratamento indicado, especialmente porque há prescrição médica fundamentada. Aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento jurisprudencial inclusive sumulado (Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça), aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre da maneira mais favorável ao consumidor, em consonância com o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.* ***IV. Necessidade de comprovação semestral de que o fornecimento dos medicamentos ainda se faz necessário. Isso porque, tratando-se de doença crônica, que exige tratamento contínuo, poderá haver modificação (na prescrição, dosagem, quantidade) dos fármacos pleiteados, motivo pelo qual se mostra razoável a exigência de comprovação semestral da continuidade do tratamento.*** *SENTENÇA MANTIDA EM PARTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA.(Recurso Cível, Nº 71008290991, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 24-07-2019) - grifei.*

Portanto, **acolho o pedido de apresentação de relatório médico pelo autor, o que deve ocorrer de forma semestral (a cada seis meses)**.

Fundamentei.

Decido.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** o pedido formulado por **CARLOS EDUARDO GORSKI** em face de **UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS** e **UNIMED PLANALTO MÉDIO/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.**, todos qualificados nos autos, a fim de:

(a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência antecipada deferida (evento 4, DESPADEC1);

(b) CONDENAR as rés, solidariamente, à obrigação de fornecer o medicamento Spravato ao autor e custear o tratamento necessário à sua aplicação, conforme disposto no atestado médico (evento 1, ATESTMED2).

Ainda, **autorizo a cobrança de coparticipação pelas rés, observando as especificações postas na cláusula 10.1.1. do contrato (evento 23, CONTR2).** E **acolho o pedido de apresentação de relatório médico pelo autor, o que deve ocorrer de forma semestral (a cada seis meses)**.

Em face da sucumbência, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa[2], com fulcro no artigo 85, §2º e §17º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimações das partes agendadas.

Interposto recurso, intime-se a parte adversa, oportunizando a apresentação de contrarrazões em 15 (quinze) dias.

Apresentadas contrarrazões com preliminares, oportunize-se nova manifestação da parte recorrente por 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §2°, do CPC.

Na abertura dos prazos, deve-se observar a prerrogativa do prazo em dobro da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Advocacia Pública, conforme artigos 180, 183 e 186 do Código de Processo Civil.

Após e na hipótese de não serem apresentadas contrarrazões com preliminares, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento.

Com o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, encaminhe-se a guia à Central de Cobranças (CC).

Após, nada sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA CAIMI, Juíza de Direito**, em 25/08/2025, às 18:58:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10089469785v23** e o código CRC **02fc0dfc**.

---

1. https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/ ↩
2. Para fins de cálculo, sobre o valor da causa deverá incidir somente correção monetária pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado da decisão de arbitramento dos honorários advocatícios. ↩